

Questions insuffisance rénale aiguë 2025

QCM 1 – Quelle(s) affirmation(s) est/sont vraie(s) selon la définition KDIGO 2012 de l'insuffisance rénale aiguë stade 1 ?

- A. Une augmentation de la créatinine sérique $\geq 26,5 \mu\text{mol/L}$ en 48h
- B. Une augmentation de la créatinine sérique $\geq 50 \%$ en 7 jours
- C. Une diurèse $< 0,5 \text{ ml/kg/h}$ pendant au moins 6 heures
- D. Une protéinurie $> 300 \text{ mg/g}$ de créatinine
- E. Une clairance de la créatinine $< 60 \text{ ml/min}$

Réponses A-B -C

QCM 2 – Stades de l'IRA selon KDIGO Quel(s) critère(s) correspond(ent) à un stade 2 d'IRA selon KDIGO 2012 ?

- A. Augmentation de la créatinine x 1,5 par rapport au taux de base
- B. Augmentation de la créatinine x 2 par rapport au taux de base
- C. Diurèse $< 0,5 \text{ ml/kg/h}$ pendant 12 heures
- D. Diurèse $< 0,3 \text{ ml/kg/h}$ pendant 24 heures
- E. Besoin d'une dialyse

Réponses B -C

QCM 3/Un patient âgé de 70 ans est admis aux urgences avec une hypotension artérielle dans un contexte de diarrhées. La créatinine est passée de $78 \mu\text{mol/l}$ à l'admission à $117 \mu\text{mol/L}$ le lendemain

A/Ce faible niveau d'élévation de la créatininémie n' a pas de valeur pronostique

B/il s'agit d'une AKI KDIGO 1

C/Une IRA fonctionnelle est la plus probable

D/une nécrose tubulaire aiguë est la plus probable

E/ l'urgence thérapeutique est l'expansion volémique

Réponses B- C- E

QCM 4/ L'IRA stade 3 est définie selon les recommandations internationales KDIGO par :

A-une baisse rapide et réversible du DFG

B-une créatininémie plus de 3 FOIS la valeur de base

C-une diurèse $< 0,3 \text{ ml/Kg/h}$ pendant plus de 24 heures

D- une anurie > 12 heures

E-une réduction du DFG de 50%

Réponses B-C-D

QCM 5/Les arguments suivants sont en faveur du caractère aigu de l'insuffisance rénale

A/Anémie normocytaire arégénérative

B/Absence d'hypocalcémie

C/ Notion de créatininémie récente normale

D/Taille de reins normale à l'échographie

E/Une hyperphosphatémie

Réponses B-C -D

QCM 6/IRA associée à une anémie est retrouvée

A/syndrome hémolytique et urémique

B/myélome multiple

C/nécrose tubulaire aiguë

D/hémorragie digestive

E/IRA fonctionnelle

Réponses A –B-D

QCM 7/IRA et hypocalcémie est retrouvée au cours de

A/la tubulopathie myélomateuse

B/ rhabdomyolyse

C/ pancréatite aiguë

D/syndrome de lyse tumorale

E/ NIA secondaire à la sarcoïdose

Réponses :B -C -D

Question 8/ Les conséquences physiopathologiques de l'insuffisance rénale aiguë sont:

A / Une hyperhydratation extra et/ou intracellulaire intracellulaire

B / Un syndrome urémique

C /une acidose métabolique

D / Une hyperkaliémie

E /Une hypokaliémie

Réponses : A –B- C-D

QCM 9/ : Quelles sont les trois principales complications de l'IRA à rechercher en urgence ?

A/Une hypercalcémie

B/Une hyperkaliémie

C/Un œdème aigu pulmonaire

D/Une alcalose métabolique

E/Une acidose métabolique

Réponses B- C-E

QCM 10/Les signes électriques suivants peuvent être observée si hyperkaliémie

A/ondes T amples pointues et symétriques diffuses

B/ un élargissement de QRS

C/une tachycardie sinusale

D/ blocs sino-auriculaires

E/Présence d'ondes U

Réponses A- B- D

QCM 11/L'hyperkaliémie peut être aggravée par :

A/Une acidose métabolique

B/la rhabdomyolyse

C /L'hémolyse

D/les vomissements

E/Le syndrome de lyse tumorale

Réponses : A-B –C- E

QCM 12/ Une insuffisance rénale aiguë est associée à une acidose sévère dans les situations suivantes :

A/ Une intoxication par l'éthylène glycol

B/une acidose lactique

C /une IRA fonctionnelle secondaire à des vomissements

D/une IRA fonctionnelle secondaire à des diarrhées

E/un état de choc septique

Réponses A B D E

QCM 13/Devant une IRA ,la cause obstructive est évoquée devant:

A/une anurie brutale

B/une hématurie macroscopique avec caillots

C/une diurèse à éclipse

D/une albuminurie

E/une anémie hémolytique

Réponses A B C

QCM 14/ Quels éléments orientent vers une IRA obstructive ?

A. Globe vésical

B. ATCD de néoplasie pelvienne

C. Une hématurie microscopique avec cylindres hématiques

D. une colique néphritique

E. un blindage pelvien au toucher vaginal et/ou au toucher rectal

Réponses A B DE

QCM 15/l'IRA obstructive :

A - survient lorsque l'écoulement de l'urine est empêché par la présence d'un obstacle unilatéral.

B – survient si l'obstacle est bilatéral.

C - survient si l'obstacle sur la voie excrétrice du seul rein fonctionnel

D - l'IRA est rapidement réversible après la libération de la voie excrétrice.

E –peut être consécutive à une fibrose rétro-péritonéale

Réponses BC D E

QCM 16/ Au cours du syndrome de levée d'obstacle , on peut constater :

A/Une diurèse horaire importante

B/une hypokaliémie

C/une déshydratation extracellulaire

D/une hypercalcémie

E/une hyponatrémie de dilution

Réponses A B C

QCM 17/ L'IRA fonctionnelle peut être secondaire à

- A/Une diarrhée profuse
- B/Un traitement par les anti-inflammatoires non stéroïdiens
- C/une insuffisance cardiaque
- D/Un syndrome néphrotique
- E/un traitement par aminosides

Réponses A B C D

QCM 18/L'IRA fonctionnelle

- A/fait suite à une déshydratation extracellulaire
- B/Peut faire suite à un syndrome néphrotique
- C/Peut survenir après un scanner avec injection de produits de contraste iodés
- D/Peut faire suite à une insuffisance cardiaque aigue
- E/est de bon pronostic si le dépistage est précoce

Réponses :A-B-D-E

QCM 19/ Dans l'insuffisance rénale fonctionnelle, Il y'a:

- A - Une perturbation de l'hémodynamique rénal.
- B - Une vasodilatation suffisante des artéioles afférentes glomérulaires.
- C - Une diminution de la filtration glomérulaire
- D - Une diminution du débit sanguin rénal.
- E - pas d'atteinte anatomique du rein

Réponses A-C-D-E

QCM 20/ Quel est le paramètre qui permet de différencier une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle d'une insuffisance rénale aiguë organique?

- A - Natrémie
- B - Créatininémie
- C - Phosphatémie
- D - Augmentation de l'urée plasmatique plus importante que celle de la créatininémie
- E - calcémie

Réponse D

QCM 21/Au cours de l'IRA FONCTIONNELLE

- A/Il existe une oligurie
- B/Le sodium urinaire est effondré
- C/Le rapport U/P de la créatinine est effondré
- D/une urée urinaire élevée
- E/ Une osmolarité urinaire à 600 mmol/L

Réponses :A-B-D-E

QCM 22/Au cours de l'IRA FONCTIONNELLE

- A/ fraction excrétée de sodium (FeNa) est inférieur à 1%
- B/La natriurèse est inférieure à 20 mmol/L
- C/ Le rapport urée/créatinine plasmatique > 60 $\mu\text{mol}/\mu\text{mol}$
- D/ Densité urinaire < 1,010
- E/ U/P osmolarité > 2

Réponses :A-B-C-E

QCM 23/Une élévation disproportionnée de l'urée par rapport à la créatinine est observée au cours de l'RA en cas de :

- A/Nécrose tubulaire aigue
- B/Hémorragie digestive
- C/Insuffisance rénale aigue fonctionnelle
- D/insuffisance hépato cellulaire associée
- E/néphrite interstitielle aigue

Réponses :B-C

Question 24/Parmi les médicaments suivants, lesquels sont impliquées dans la survenue d'IRA pré-rénales ?

- A Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion
- B. Le paracétamol
- C. Les diurétiques
- D Les inhibiteurs de la calcineurine
- E.Les statines

Réponses :A-C-D

QCM 25/Les médicaments suivants induisent une IRA hémodynamique par une vasoconstriction de l'artériole afférente réversible :

A/Les AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens)

B/Les anti calcineurine (ciclosporine, tacrolimus)

C/IEC

D/IPP

E/BSRA

Réponses :A-B

QCM26/L'insuffisance rénale aigue secondaire aux AINS peut être secondaire à :

A/Hémodynamique

B/Nécrose tubulaire aigue

C/Des lésions glomérulaires minimes

D/Néphrite interstitielle aigue

E/Hyalinose segmentaire et focale

Réponses :A-B-D

QCM 27/Les insuffisances rénales aigues hémodynamiques peuvent être secondaire à

A/les inhibiteurs de l'enzyme de conversion

B/les aminosides

C/la ciclosporine

D/empagliflozine

E/anti-inflammatoires non stéroïdiens

Réponses :A- C- D- E

QCM 28/Quelle est la cause d'IRA organique la plus fréquente ?

A/ Une Glomérulonéphrite Rapidement Progressive secondaire à une vascularite nécrosante à ANCA

B/ Une Néphrite Interstitielle Aiguë médicamenteuse

C/ Un Syndrome Hémolytique et Urémique

D/ Une Nécrose Tubulaire Aiguë

E/ Une thrombose bilatérale des artères rénales

Réponse :D

QCM 29/Une patiente âgée de 55 ans est hospitalisée en néphrologie pour insuffisance rénale aiguë .PA 120/70 Bandelettes urinaires P +h 0

- **Dosage pondéral prot 0,1 g/24 h**

Il s'agit d'une IRA organique Le tableau correspond à:

A/Une GNRP

B/Une néphropathie vasculaire aiguë

c/une atteinte tubulo-interstitielle aiguë

D/syndrome néphritique

E/une néphropathie vasculaire aiguë

Réponse :C

QCM 30/Une IRA par nécrose tubulaire aiguë peut compliquer

A/Une coronarographie

b/Une pancréatite aiguë

c/ Une rhabdomyolyse

d/Un Etat de choc septique persistant

e/Un traitement par purinol

Réponses :A-B-C-D

QCM 31/ L'insuffisance rénale aiguë par précipitation intratubulaire peut être secondaire à

A/Une rhabdomyolyse

B/une hémolyse

C/Un traitement par Aciclovir

D/Un myélome multiple

E/ traitement par des aminosides

Réponses :A-B-C-D

QCM 32/En cas d'insuffisance rénale aiguë (IRA), le furosémide est indiqué lorsqu'il s'agit des signes de surcharge hydrosodée secondaire à :

A-Une glomérulonéphrite extra-capillaire

B-Une nécrose tubulaire aiguë secondaire à un traitement par aminosides

C-Une IRA par glomérulonéphrite aiguë post infectieuse

D-Une IRA par néphrite interstitielle aigue immunoallergique.

E-Une IRA obstructive

Réponses A-B-C-D

QCM 33/Les Facteurs de risque d'IRA post injection de produits de contraste sont :

A/Une IRC préexistante

B/Une hypovolémie

C/Des fortes doses du produit de contraste iodé

D/une hépatopathie

E/Une insuffisance cardiaque

Réponses A B C E

QCM 34 /Chez un patient diabétique de type 2 devant bénéficier d'une coronarographie, quelles sont les principales mesures prophylactiques à préconiser pour éviter la néphropathie des produits de contraste iodés ?

A/ Arrêt d'un traitement diurétique avant l'examen

B/ Hydratation per os la veille de l'examen dans les 12 heures qui suivent

C/ Administration de furosémide juste avant et après l'injection d'iode

D/Hémodialyse en urgence après l'administration d'iode

E/ Utilisation de produits iodés hypo-osmolaires

Réponses :A-B-E

QCM 35/ Parmi les propositions suivantes concernant l'insuffisance rénale aiguë secondaire à la maladie des embols de cholestérol, cochez la ou les bonnes réponses :

A/ Elle peut survenir après un geste endovasculaire

B/ Elle peut survenir après une anticoagulation

C/ la récupération de la fonction rénale est la règle

D/ Elle peut s'accompagner de livedo

E/ L'examen ophtalmologique avec fond d'œil peut aider au diagnostic

Réponses :A-B-D-E

QCM 36/ Concernant la maladie des embols de cholestérol, Elle peut s'accompagner d':

A. un syndrome inflammatoire biologique

B. Une hypocomplémentémie

C. Une hyperéosinophilie

D. Une lymphopénie

E. ANCA positifs

Réponses :A-B-C

QCM 37/Une nécrose tubulaire par précipitation intratubulaire de certains médicaments peut être observée avec

A/l'aciclovir

B/la sulfadiazine

C/les aminosides

D/l'indinavir

E/Les AINS

Réponses :A-B-D

QCM 38/Une NTA SECONDAIRE A UNE PRECIPITATION INTRATUBLAIRE peut secondaire à :

A/Traitement par l'Aciclovir

B/Traitement par les aminosides

C/Rhabdomyolyses

D/Hémolyses massives

E/Tubulopathie myélomateuse

Réponses :A-C-D-E

QCM 39/Les arguments suivants sont en faveur d'une insuffisance rénale aigue secondaire à une rhabdomyolyse

A/une protéinurie <1 g/24 heures

B/une hématurie à l'ECBU et aux bandelettes urinaires

C/une hématurie à la bandelette urinaire non confirmée à l'ECBU

D/une élévation des enzymes musculaires

E/une hypokaliémie

Réponses :A –C-D

QCM 40/Au cours d'une IRA par rhabdomyolyse

A /la calcémie est basse initialement

B /il y a une hyperkaliémie majeure

C/ une hématurie microscopique est habituelle à L'ECBU

D /la phosphatémie est très élevée

E /peut être de cause médicamenteuse

Réponses :A-B-D-E

QCM 41/L'IRA par syndrome de lyse tumorale :

A/Survient le plus souvent après une chimiothérapie

B/Est caractérisé par une hypophosphatémie

C/Il y a une hypocalcémie

D/le mécanisme principal est la précipitation d'acide urique et de phosphate de calcium

E/Est favorisée par la déshydratation

Réponses :A-C-D-E

QCM 42/En faveur de l'IRA organique par Néphropathie interstitielle aigue immunoallergique

A-Une tension artérielle normale

B-Une réintroduction de l'allopurinol

C-Un rash cutané concomitant

D- Une protéinurie abondante

E- Une hématurie microscopique aux bandelettes urinaires

Réponses A-B-C-E

QCM 43/En faveur de l'IRA organique par Néphropathie glomérulaire aigue

A- des œdèmes de type rénal

B-Une hypertension artérielle

C-Des signes extrarénaux associés

D- Une protéinurie à 0.5 g /24 heures

E- Une hématurie microscopique aux bandelettes urinaires

Réponses A-B-C-E

QCM 44/Concernant l'insuffisance rénale aiguë associée à un syndrome néphritique,

A. Elle est associée à une hématurie et une protéinurie

B. Une HTA et des œdèmes peuvent faire partie du tableau clinique initial

C. Une NIA immunoallergique peut être responsable de ce tableau

D. . Une hématurie macroscopique initiale est possible

E. . La présence d'une oligurie est possible

Réponses :A –B-D-E

QCM 45/Concernant les glomérulonéphrites rapidement progressives (GNRP), quelles sont les affirmations exactes ?

A. Le tableau associe une insuffisance rénale rapidement progressive et une hématurie glomérulaire

B. L'hypertension artérielle est sévère dans ce tableau

C. . La protéinurie est habituellement < 1 g/24 h

D. Constitue une urgence diagnostique et thérapeutique

E. . Une hématurie macroscopique est possible dans ce contexte

Réponses :A-D-E

QCM 46/Concernant le syndrome hémolytique et urémique (SHU), quelles sont les affirmations exactes ?

A. Il associe typiquement une anémie hémolytique mécanique, une thrombopénie et une insuffisance rénale aiguë

B. La présence de schizocytes au frottis sanguin est un élément clé du diagnostic

C. Une baisse de l'haptoglobine et une augmentation des LDH sont évocatrices

D. Le SHU s'accompagne d'une coagulation intravasculaire disséminée dans la majorité des cas

E. Une HTA est rarement retrouvée

Réponses :A-B-C

QCM 47/Les indications d'épuration extra-rénale en cas d'insuffisance rénale aigue:

A/œdème aigu du poumon réfractaire aux diurétiques

B/hyperkaliémie à 5,1

C/Ph à 7,05

D/une oligurie

E/une TA à 190/100 mmHg

Réponses :A-C

QCM 48/Les situations suivantes sont des indications d'une séance de dialyse en urgence

A/ph à 7, 34

B/Une protéinurie à 5,2 g/24 heures

C/Un Œdème aigu du poumon

D/Hyperkaliémie à 6,7 avec des signes électriques

E/une hématurie macroscopique

Réponses :C-D

QCM 49/En cas d'acidose métabolique, l'épuration extrarénale est indiquée en cas

A/Ph à 7,05

B/une acidose lactique

C/Une intoxication par l'éthylène glycol

D/Une intoxication par le méthanol

E/ Ph à 7, 3

Réponses :A-B-C-D

QCM 50/Un patient a consulté les urgences pour insuffisance rénale aigue anurique et oedème aigu du poumon avec à la biologie hyperkaliémie à 6,8 mmol/L, ph à 7,3

Echographie rénale sans anomalies, quel(s) traitement(s) à instaurer en attendant l'épuration extra rénale

A/Gluconate de calcium IVL

B/Furosémide

C/Bicarbonate de sodium

D/Insuline ordinaire avec serum glucosé 5%

E/Oxygénothérapie

Réponses :A-B-D-E

QCM 51/La corticothérapie est indiquée au cours des insuffisances rénales aigues organiques secondaires à

A. Une nécrose tubulaire aigue

B. Une néphropathie interstitielle aigue infectieuse

C. Une glomérulonéphrite extra-capillaire

D. Une néphropathie lupique

E-Une néphropathie interstitielle aigue immunoallergique

Réponses :C-D-E

QCM 52/Les facteurs de risque de la néphrotoxicité aux produits de contraste iodés

A /L'insuffisance cardiaque

B/L'hypovolémie

C/une insuffisance rénale chronique préexistante

D/une hypertension artérielle

E/Le myélome multiple

Réponses :A-B-C-E

QCM 53/Devant une insuffisance rénale aiguë par nécrose tubulaire aiguë :

A/Les diurétiques sont contre indiqués

B/Le traitement est basé sur la réhydratation

C/Le recours à l'hémodialyse est fréquent

D/L'anurie est constante

E/La Récupération de la fonction rénale est habituelle

Réponses :C-E

Cas cliniques

Cas clinique 1 :Un homme de **50 ans**, avec des **antécédents de lithiases urinaires**, consulte aux urgences pour colique néphrétique, évoluant depuis 24 heures. Il signale des nausées sans vomissements ni fièvre. Il n'a pas uriné depuis 12 heures.

À l'arrivée aux urgences :TA : 140/85 mmHg , FC : 95 bpm , Température : 37,2 °C

Examen clinique : douleur à la percussion lombaire droite

Sonde urinaire: pas d'urines

Biologie initiale : Créatinine : 220 µmol/L , Kaliémie : 4,8 mmol/L , Bicarbonates : 20 mmol/L

QCM 1 / Quel examen d'imagerie faut-il réaliser en urgence ?

A. Scanner abdominal sans injection

B. Échographie rénale

C. Urographie intraveineuse (UIV)

D. Radiographie de l'abdomen sans préparation (AUSP)

E. IRM abdomino-pelvienne

Réponse B

Biologie de contrôle réalisé après quelques heures : Créatinine : 520 µmol/L Kaliémie : 7,1 mmol/L Bicarbonates : 7 mmol/L

Échographie rénale : Calcul obstructif droit de 10 mm avec dilatation pyélocalicielle droite
Rein gauche non visualisé,

QCM 2/ Quelle(s) prise(s) en charge immédiate(s) recommandez-vous dans ce contexte ?

- A. hémodialyse en urgence
- B. Prescription de diurétiques de l'anse par voie intra-veineuse
- C. Alcalinisation des urines par bicarbonates de sodium par voie intra-veineuse
- D. Administration de gluconate de calcium par voie intra-veineuse lente
- E. administration de résine échangeuse d'ions : Kayexalate

Réponses :A-D

QCM 3 /Concernant la cause de cette insuffisance rénale aiguë, quelles propositions sont exactes ?

- A. Il s'agit d'une IRA obstructive par obstacle unilatéral sur rein unique
- B. Il s'agit d'une IRA par rétention urinaire aiguë avec globe vésical
- C Il s'agit d'une IRA obstructive par obstacle bilatéral
- D. Elle est secondaire à une néphrite interstitielle aiguë
- E. Elle est secondaire à une pyélonéphrite aiguë

Réponse :A

QCM 4/ Quelle est l'attitude thérapeutique dans ce contexte ?

- A .Drainage des voies urinaires par néphrostomie percutanée droite
- B.Pose d'une sonde double J droite
- C.Antibiothérapie
- D.cathéter sus -pubien
- E.lithotritie extra-corporelle

Réponses :A-B

Cas clinique n 2

Une patiente âgée de 43 ans sans antécédents pathologiques, admise pour PEC d'une tuberculose ganglionnaire et iléocaecale

Quadrithérapie anti-tuberculeuse débutée

A j03 : Rash cutané généralisé

A l'examen: PA 110/60mmHg , Auscultation cardiopulmonaire sans anomalies , Pas d'œdème des membres inférieurs. BU: Protéinurie++ hématurie+ leucocyturie++

Biologie: urée 8 , Créatininémie 209 mmol/l, Protéinurie 0,7 g/24h

ECBU: L20 H30 culture négative

QCM 1/ Devant cette IRA le diagnostic le plus probable est

A/Une nécrose tubulaire aigue

B/une IRA fonctionnelle

C/une GNA post infectieuse

D/une néphropathie lupique

E/une NIA immunoallergique

Réponses :E

QCM 2/ Les lésions histologiques possibles sont

A/Une prolifération endocapillaire

B/une prolifération extracapillaire

C/une nécrose tubulaire aigue

D/un infiltrat interstitiel

E/un œdème interstitiel

Réponses :D-E

La rifampicine a été incriminée

QCM 3-La prise en charge thérapeutique comprend :

A/une épuration extra-rénale

B/une réhydratation

C/arrêt du traitement incriminé

D/la poursuite de ce traitement

E/un traitement immunosuppresseur

Réponse :E

QCM 4 /Les signes biologiques en faveur de ce diagnostic sont :

A/Une leucocyturie

B/Une protéinurie à 0 ,8 g /24 heures

C/Une hématurie à 80 E/mm³

D/une hyperéosinophilie

E /CPK légèrement élevée

Réponses:A-B-C-D

Cas clinique N 3

Un patient âgé de 72 ans ayant comme **antécédents** :

-une hypertension artérielle depuis 10 ans sous Perindopril , Amlodipine, Furosémide

-une dyslipidémie depuis 8 ans sous simvastatine

une AOMI, un pontage aorto-fémoral est prévu. IL avait bénéficié d'une artériographie pré-revascularisation (créatinine avant la revascularisation à 80 µmol/L)

Vous êtes sollicités pour un avis à J 5 devant l'aggravation des chiffres de créatinine :

PA 130/70 mmHg , pas d'œdèmes des membres inférieurs

Diurèse à 300 ml/24 heures . Urines :prot traces Hu 0 leucocyturie -

Bilan réalisé à J 5 : Na 130 mmol/l K 5,1mmol/L HCO₃- 18 **créatinine 400 µmol/L**
Hémoglobine 11, 6 g/dl

Natriurèse urinaire 35 mmol/24 h FENa + 2, 2%

Prot de 24 heures 0, 7 g/24 heures

QCM 1/ Le diagnostic le plus probable est

A/Une IRA fonctionnelle

B/une nécrose tubulaire aiguë

C/une maladie des embolies de cholestérol

D/une NIA immuno-allergique

E/une glomérulonéphrite extra-capillaire

Réponse : B

QCM 2/Les arguments cliniques en faveur de ce diagnostic sont :

A/une hypotension orthostatique

B/un livedo

C/un purpura

D/l'absence de signes extra-rénaux

E/les constatations de la bandelette urinaire

Réponses :D-E

QCM 3/Les arguments biologiques en faveur de ce diagnostic sont :

A/ FE Na + 2.2%

B/protéinurie à 0,7 g/24 heures

C/une hémococoncentration

D/une hyperéosinophilie

E/osmolarité urinaire élevée

Réponses :A-B

QCM 4/Les facteurs de risque de cette IRA

A/Age

B/une hypovolémie associée

C/traitement diurétique

D/Volume important de PCI

E/ATCD d'hypertension artérielle

Réponses :A-B –C-D

Cas clinique N 4

Un patient âgé de 45 ans consulte aux urgences pour asthénie et vomissements

Diurèse estimée à 600 cc/24 heures puis à 100 cc/24 heures

L'examen clinique révèle des OMI ,TA 140/80 mmHg

BU prot+++ H+++

NFS: GB:6500 E/mm³ , HB:11 , plaquettes :180000^{E/mm³}

Echographie rénale sans anomalies

QCM 1/Quel atteinte histologique doit faire évoquer chez ce patient la constatation d'une protéinurie à 2,5 g/24 H, d'une Hématurie avec une insuffisance rénale rapidement progressive ?

A- une néphropathie interstitielle

B- une amylose

C- Glomérulonéphrite extra capillaire

D- Néphroangiosclérose bénigne

E- Glomérulonéphrite membrano proliférative

Réponse :C

QCM 2/Les explorations suivantes sont nécessaires à but étiologique

A/Ponction biopsie rénale

B/Biopsie des glandes salivaires accessoires

C/dosage des anti MBG

D/Dosage des ANCA

E/ recherche de schizocytes

Réponses :A-C-D

QCM 3/ Le patient avait comme signes extra-rénaux une épistaxis, le diagnostic le plus probable est

A/polyangéite microscopique

B/granulomatose ave polyangéite :maladie de wegener

C /syndrome de Goodpasture

D/périartérite noueuse

E/cancer du cavum

Réponse :B

QCM 4 – Quel est le traitement proposé devant ce tableau clinique

A.Antibiothérapie

B. Corticothérapie

C. Immunosuppresseur

D. Plasmaphérèse (échange plasmatique)

E. hydratation par du sérum isotonique

Réponses :B-C-D

Cas clinique N 5

Mme G, âgée de 76 ans, est hospitalisée pour insuffisance rénale aigue

ATCD: HTA traitée par ramipril 5 mg + hydrocholothiazide 12,5 mg/j

Dyslipidémie sous Atorvastatine 20 mg 1 cp/

HDM: Gastroentérite avec diarrhée abondante depuis 3 jours

Examen clinique: poids à 60 Kg (était à 65 Kg)

PA = 120/60 mmHg couchée, pouls 70 /min, PA debout à 100 /50 mmHg, pli cutané persistant

Apyrétique. Abdomen souple. Reste de l'examen normal.

Biologie: Sang : Créatinine 420 $\mu\text{mol/l}$ (créat à 85 il y a 6 mois), urée 46 mmol/l , acide urique 620 ,LDH 180 , Na 130 mmol/L, K 5,1 mmol :l, protide 87g/L, RA 15 mmol/l .

Hématocrite à 51%

Une échographie rénale :pas de dilatations des voies excrétrices , vessie vide .

QCM 1/Vous évoquez

A/une IRA fonctionnelle

B/une nécrose tubulaire aigue

C/une rétention aigue d'urines

D/Une néphropathie interstitielle aigue

E/une IRA obstructive

Réponse :A

QCM 2/ Les arguments cliniques en faveur du diagnostic sont :

A/les diarrhées

B/pli cutané persistant

C/tension artérielle debout à 100/50 mmHg

D/initiation du traitement par statines

E/pouls à 70 cycles/min

Réponses :A-B-C

QCM 3 /Les arguments biologiques en faveur de ce diagnostic

A/élévation disproportionnée de l'urée par rapport à la créatinine

B/protidémie à 87 g/L

C/Taux de LDH à 180

D/Uricémie à 660

E/Hématocrite à 51%

Réponses :A-B-D-E

QCM 4/Les arguments biologiques urinaires à rechercher en faveur de ce diagnostic

A/[Na] urinaire > 20 mmol/L

B/FENa < 1%

C/Fraction d'excrétion d' acide urique < 35%

D/ L'osmolalité urinaire > 300 mOsm/Kg

E/ Urée Urinaire/urée Plasmatique >10

Réponses :B-C-D-E

QCM 5/La conduite thérapeutique pour ce patient

A/poursuite du diurétique thiazidique

B/Arrêt ramipril

C/Arrêt statines

D/perfusion du sérum physiologique à 9‰

E/perfusion du sérum glucosé 5%

Réponses :B-D